Escribas digitales

Qué son, por qué importan y cómo evaluar su encaje

De la consulta a una **nota clínica revisada**.

Para un hospital con atención en español y **Dedalus HCIS**, el sistema de historia clínica del hospital.

10 minutos · 5 bloques

1. Qué es
2. Por qué importa
3. Mercado y encaje
4. Discusión: cómo evaluar
5. Conclusión y siguientes pasos

INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL DE INVESTIGACIÓN SANITARIA IR-yCIS

Propuesta: comprobar calidad y utilidad local antes de elegir una solución.

Fuentes: Informe completo y guion del proyecto, 18/09/2026. Investigación adicional y comprobaciones selectivas: 07/10/2026. Revisión documental.

Un asistente para documentar la consulta

El médico conversa con el paciente; el escriba prepara la nota.



Consulta + contexto

Voz · datos clínicos

↓

Borrador de nota

Información organizada

↓

Revisión del médico

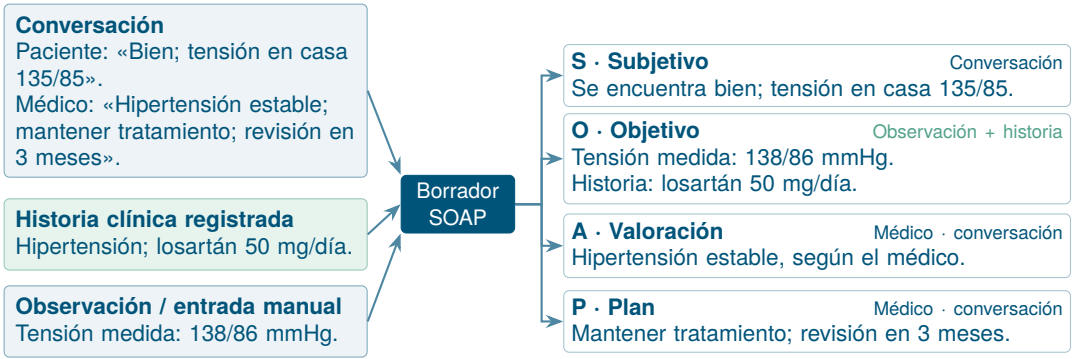
Aprueba y guarda en HCIS

Historia y observaciones, cuando están disponibles. El médico revisa y aprueba.

Fuentes: NHS England, v3, 2026; Nabla: transcripción y contexto. Esquema conceptual; ilustración generada con IA como metáfora del asistente.

Ejemplo: de tres fuentes a una nota SOAP

Caso ficticio de seguimiento de hipertensión · cada dato conserva su origen.



Valoración y plan expresados por el médico; contexto de HCIS pendiente de confirmar.

Fuentes: Ejemplo propio, ilustrativo. SOAP: Subjetivo, Objetivo, Valoración (Assessment) y Plan. La ubicación de medicación puede variar según la plantilla.

El beneficio que buscamos: menos carga documental

Recuperar atención y tiempo a lo largo de la jornada.



Menos teclado

durante la consulta



Más atención

al paciente



Menos pendientes

al terminar

Proyección ilustrativa

≈5 h/mes

menos de documentación por profesional

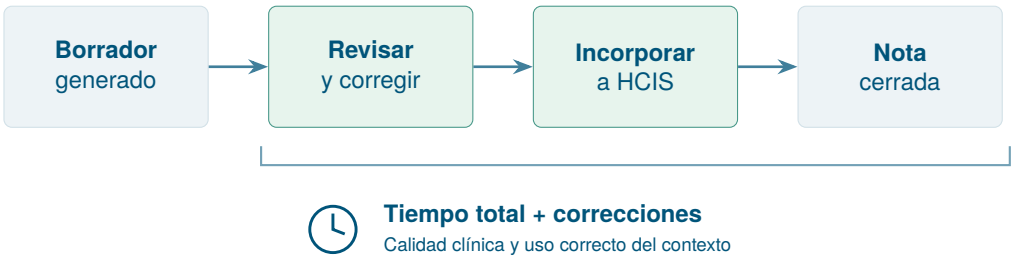
Base: 16 min menos por 8 h de consulta programada

Ejemplo: 8 h de consulta/día · 220 días/año

Fuentes: Rotenstein et al., JAMA, 2026: asociación observada en cinco centros de EE. UU. Cálculo propio: 4,9 h/mes medio con efecto constante. No reducción demostrada de jornada. Objetivos superiores por evaluar localmente.

Hay que medir hasta que la nota queda cerrada

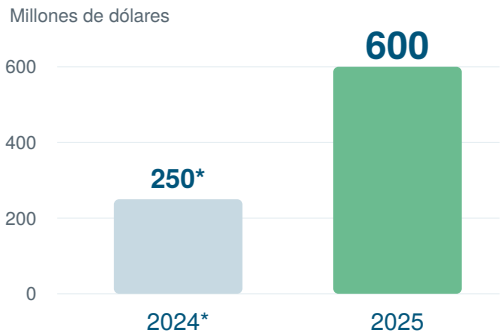
El ahorro depende del trabajo que sigue al borrador.



Fuentes: Propuesta local de evaluación. JAMA, 2026; Biro et al., 2025. La comparación con el flujo habitual debe incluir revisión, corrección y cierre.

El mercado de escribas crece con rapidez

Ingresos estimados de escribas ambientales · Menlo Ventures, 2025.



×2,4

en ingresos, en un año

PHTI: entre las adopciones más rápidas de la sanidad reciente

Valoración sectorial · 2025

Fuentes: Menlo Ventures, 2025: estimación de ingresos, EE. UU.; fuente inversora. *2024 derivado: 600/2,4. PHTI, 25/03/2025: valoración basada en entrevistas y grupo de expertos, sin ranking histórico cuantitativo.

Muchas ofertas; varias formas de llegar al hospital

Cuatro familias orientativas, que se solapan.

43
soluciones y proyectos en nuestro inventario
Septiembre de 2026
Muestra documental

Quirónsalud: proyecto propio
Referencia de implantación

Uso individual
Heidi · Noa · Freed

Oferta hospitalaria
Tandem · Invox · Align

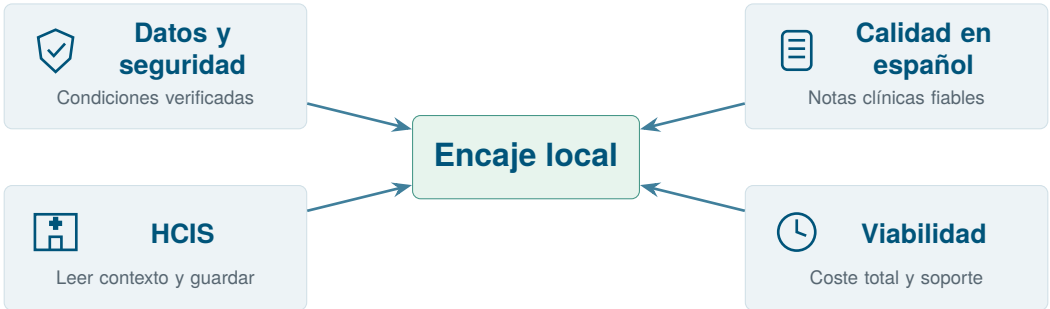
Con la historia clínica
Microsoft · Oracle · Abridge

Para construir con APIs
Corti · AWS

Fuentes: Inventario del informe: 09/09/2026 + AWS, 17/09. Familias orientativas. Quirónsalud: proyecto implantado en su red; sin oferta de API comercial acreditada aquí. El recuento no es un censo de proveedores comerciales.

El encaje que buscamos tiene cuatro piezas

Una buena demo debe convertirse en un flujo viable en nuestro hospital.



Fuentes: Requisitos propuestos en el informe del proyecto: datos, seguridad, calidad, integración y coste. HCIS exige comprobar paciente/episodio, lectura de contexto y devolución de la nota revisada.

Hay candidatos; el encaje sigue por demostrar

Selección corta del informe · principal incógnita visible: el flujo con HCIS.

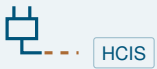
Tandem



HCIS no disponible

según su ficha pública

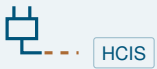
Invox Genesis



API disponible

conector HCIS por demostrar

Solventum Align



Integración HCE

HCIS específico por confirmar

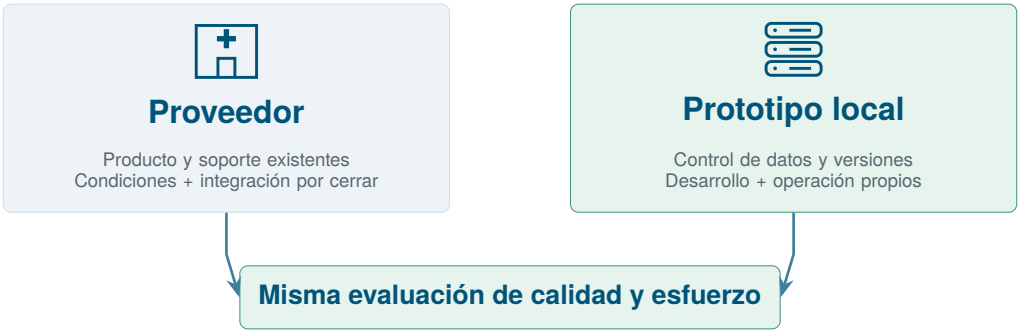
También por cerrar para esta selección

- Calidad clínica local
- Expediente de datos
- Coste total

Fuentes: Tandem HCIS; Invox API; Align. Revisión selectiva 09/10/2026; declaraciones comerciales, sin prueba funcional. Falta de evidencia local no implica imposibilidad técnica.

Dos vías que podemos poner a prueba

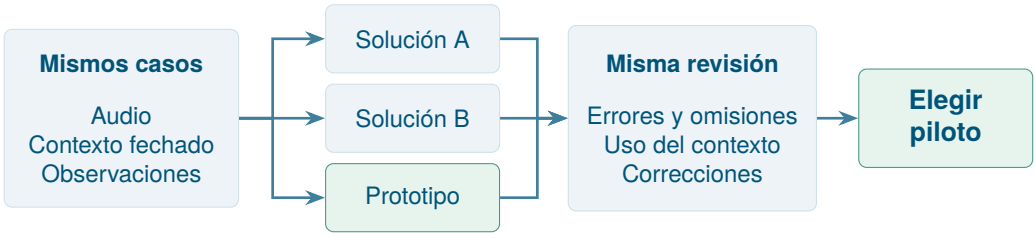
La vía local es una opción de exploración, sujeta a recursos.



Fuentes: Propuesta del proyecto. Referencias exploratorias: OpenScribe, Phlox; sin instalación ni validación local. Un prototipo local también necesita seguridad, mantenimiento e integración.

Los mismos casos permiten una comparación justa

El banco de casos sirve para decidir qué solución merece un piloto.

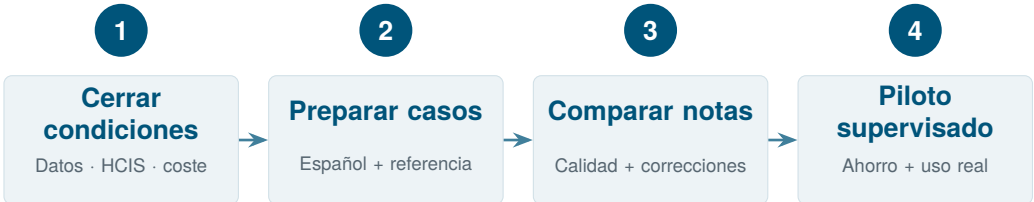


Pruebas repetibles por lotes + revisión clínica de muestras y casos señalados

Fuentes: Diseño propuesto, basado en Biro et al., 2025 y Zhou et al., 2025. Casos de ajuste separados de evaluación; revisión clínica. El ahorro real se comprueba después, en el piloto asistencial.

Siguiente paso: comparar antes de pilotar

Cada etapa deja un resultado que permite decidir la siguiente.



Decisión del siguiente hito: qué solución pilotar y con qué condiciones

Fuentes: Propuesta del proyecto: requisitos y criterios de éxito por acordar; candidatos y posible comparador local. El piloto procede si la comparación acredita calidad y viabilidad suficientes.

La decisión ahora: iniciar una evaluación local

La oportunidad está clara. El encaje debe demostrarse en nuestro flujo.

Elegir qué pilotar con evidencia propia.



Notas fiables



Menos trabajo



Integración HCIS

Para arrancar: un servicio · responsables clínico y técnico · recursos acotados

Fuentes: Conclusión y propuesta del proyecto. Próximo entregable: comparación de calidad, esfuerzo e integración para decidir el alcance del piloto.